

21 - 05- Contraception - Pr. Asmouki

(0:02 - 0:24)

Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule la contraception. Alors, comme définition, la définition d'une méthode contraceptive, c'est toute méthode permettant d'empêcher la survenue d'une grossesse pendant une période désirée. Et il en existe plusieurs méthodes.

(0:25 - 0:41)

Alors, chimique, mécanique, hormonale. La contraception doit être efficace, acceptable et non nuisible à la santé. Donc, sauf cas particulier, c'est la femme qui choisit sa contraception.

(0:42 - 0:58)

Parce qu'elle va la prendre pendant plusieurs années. Il doit absolument être bien accepté par la femme. Les différents types, il y a les hormonales, ceux qui ont une action mécanique, les méthodes chimiques qu'on va voir par la suite.

(1:01 - 1:26)

Alors, les objectifs de ce cours sur la contraception, savoir énumérer les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Bien sûr, relever les contre-indications de chaque méthode contraceptive. Tout ça pour pouvoir prescrire une pilule contraceptive.

(1:29 - 1:46)

Dans les autres cas, pour prescrire un dispositif intra-utérin. Et on va également parler de comment prescrire une contraception d'urgence. Pour atteindre ces objectifs, nous avons opté pour le plan suivant.

(1:47 - 1:56)

En généralité, on va parler essentiellement de la contraception hormonale. Du dispositif intra-utérin. Et à la fin, de la contraception d'urgence.

(1:59 - 2:25)

Dans la contraception hormonale, il y a deux grandes catégories qu'il va falloir connaître quand on parle de contraception hormonale. Soit on utilise les gestes progestatifs combinés, soit on utilise les progestatifs seuls. On va voir par la suite la différence entre les deux types de contraception.

(2:26 - 2:45)

Bien sûr, il faut savoir prescrire et surveiller cette contraception. Alors, en généralité, la contraception permet la régulation des naissances. C'est à dire qu'on va éviter la survenue de grossesses non désirées.

(2:46 - 3:11)

On va pouvoir espacer les grossesses pour le bien de la femme et du couple et des enfants. Bien sûr, qui dit diminuer les grossesses non désirées, ça veut dire diminuer le problème des interruptions volontaires de grossesse. C'est un problème de société et de santé publique.

(3:11 - 3:47)

S'il y a des grossesses non désirées, on sait tous qu'il va y avoir recours à des interruptions de grossesse. Chose qui est illégale, qui se fait dans des conditions non médicales et qui peuvent entraîner des complications très graves. La consultation pour la contraception, c'est également un moment où on a un contact avec la patiente pour dépister certaines pathologies, notamment les MST, le VIH ou le cancer, notamment le cancer du col utérin.

(3:48 - 4:06)

C'est une occasion pour délivrer d'autres objectifs. Toutes les méthodes contraceptives, on les compare par leur efficacité. Cette efficacité se mesure par l'indice de perles.

(4:07 - 4:44)

L'indice de perles, c'est le nombre de grossesses accidentelles sur le nombre de cycles observés multiplié par 1200. Ça désigne le nombre de grossesses accidentelles pour 100 femmes au cours d'une année. Les méthodes contraceptives sont classées en fonction de leur efficacité.

(4:45 - 5:13)

Il y a quatre grandes catégories. Celles qui sont toujours très efficaces, que ce soit en utilisation courante ou bien en utilisation optimale. Toujours très efficaces, c'est la catégorie qui a le plus grand taux d'efficacité.

(5:14 - 5:55)

Ça relève par le fait que le risque d'échec est inférieur à 1% à les femmes, quel que soit l'utilisation. Dans ces méthodes-là qui sont toujours très efficaces, les ongles fonds, on les appelle les tier 1. Les top tier, il y a les implants à la progestérone avec des indices de perles très bons. Les vasectomies et les stérilisations féminines, c'est les méthodes chirurgicales.

(5:57 - 6:26)

Les progestatifs injectables, qui ont également des indices parce qu'on fait une injection tous les

trois mois, et si c'est bien respecté, les taux d'échec sont vraiment très très bons. On va parler également du dispositif intra-utérin, une fois qu'il est utilisé, le risque d'échec est très très très faible. Alors ceci concernant les méthodes qui sont toujours très efficaces.

(6:27 - 6:42)

Il faut les connaître parce que ça peut être l'objet de questions. Donc la deuxième catégorie, ce sont des méthodes qui sont efficaces lorsqu'elles sont bien utilisées. Efficaces dans leur emploi courant.

(6:44 - 7:08)

Donc on va voir dans leur emploi courant, des taux qui sont inférieurs à 1% à les femmes. Donc elles sont efficaces lorsqu'elles sont utilisées, lorsque l'utilisation est optimale. Dans cette catégorie, on trouve la pilule oestroprogestative combinée.

(7:08 - 7:31)

La pilule oestroprogestative combinée, vous voyez, elle a un très bon taux lorsqu'elle est très bien utilisée, lorsqu'il y a une utilisation optimale. Mais dans la vraie vie, dans la vraie vie, lorsqu'elle ne s'est pas bien utilisée, lorsqu'il y a des oublis, le taux d'échec des deux sites est à 8%. C'est pour cela qu'elles ne sont pas classées parmi les toujours très efficaces.

(7:31 - 7:58)

Elles sont classées parmi les méthodes efficaces lorsqu'elles sont utilisées de façon optimale. Il y a également des méthodes qui sont très efficaces lorsqu'elles sont correctement utilisées régulièrement. Donc dans cette catégorie, il faut essentiellement retenir la contraception orale, qui n'est pas une méthode toujours très efficace, mais elle est efficace lorsqu'elle est utilisée correctement.

(8:02 - 8:23)

La dernière catégorie, ce sont des méthodes qui ont une certaine efficacité dans leur utilisation courante. Elles ont des indices de perte qui sont élevés, au-delà de 3%, même en utilisation optimale. On montre ici le préservatif, le diaphragme et les spermicides.

(8:25 - 8:48)

Donc, retenir trois grandes catégories, les toujours efficaces, quels que soient leurs modes d'utilisation, les efficaces lorsqu'ils sont très bien utilisés. Là, on trouve la pilule extra-progestative et les pilules progestatives pures en dehors de l'allaitement. Il y a des méthodes qui sont moins efficaces, mais qui peuvent aider.

(8:49 - 9:12)

Elles sont utilisées essentiellement, elles accompagnent les autres méthodes, notamment le préservatif, parce qu'il a en plus une certaine action contraceptive. Il a une action pour la protection contre les infections sexuellement transmissibles. Alors, on va commencer par le grand chapitre qui est la contraception hormonale.

(9:13 - 9:38)

Comme on a dit, il y a les extra-progestatifs et les progestatifs seuls. Alors, dans les extra-progestatifs, la pilule extra-progestative, on va essentiellement parler de la pilule combinée, parce que toutes les pilules extra-progestatives actuellement qui sont disponibles, ce sont des pilules qui sont combinées. C'est-à-dire que tous les comprimés contiennent de l'oestrogène et de la progestérone.

(9:40 - 10:02)

Le deuxième extra-progestatif qui est utilisé dans la contraception hormonale, extra-progestatif, c'est l'anon vaginal. Le troisième produit, je ne pense pas qu'il existe au Maroc, c'est le patch extra-progestatif. Alors, c'est le produit qui délivre de l'oestradiol et un progestatif durant la période où ils sont utilisés.

(10:03 - 10:29)

Ceci concerne les contraceptions hormonales par les extra-progestatifs. Alors, pour la contraception hormonale qui n'utilise que la progestérone, le progestatif seul, il y a ceux qui sont pris par voie orale, c'est les fameux micro-progestatifs qui sont très utilisés, surtout après l'accouchement, et dans les contre-indications de la pilule extra-progestative. Il y a ceux qui sont injectables.

(10:30 - 10:51)

Il y a ceux qui sont implantables, les implants. Et il y a ceux qui sont utilisés dans le dispositif interacteur, c'est le dispositif interacteur à la progestérone. Alors, pour les oestros-progestatifs combinés, la première catégorie de la contraception hormonale, l'oestrogène qui est utilisé, c'est toujours l'éthylénide extra-diol.

(10:53 - 11:23)

Toutes les pilules, la majorité des pilules qui sont actuellement disponibles, ce sont des pilules minidosées, c'est-à-dire que cette quantité d'éthylénide extra-diol est inférieure à 50 microgrammes d'éthylénide extra-diol. Donc, l'éthylénide extra-diol, dans les minidosés, c'est inférieur à moins de 50 milligrammes d'éthylénide extra-diol. Et bien sûr, combinés, c'est-à-dire qu'ils sont associés à un progestatif.

(11:24 - 11:59)

Alors, ils sont minidosés, et c'est le progestatif qui fait le type de pilule oestro-progestative combinée. Il y a ceux de la première génération, c'est-à-dire qu'ils contiennent un progestatif de première génération, qui sont connus par leurs effets androgéniques et leurs effets métaboliques. Ceux qui contiennent un progestatif de deuxième génération, généralement, c'est le levonorgestrel, ils ont un peu moins d'effets androgéniques, un peu moins d'effets métaboliques.

(12:00 - 12:28)

Mais ils sont très largement utilisés, en première intention, parce que c'est des pilules qui ont montré un certain avantage par rapport à ceux de la troisième génération. Alors, ceux de la troisième génération, c'est vrai, ils ont un effet anti-gonadotrope puissant, ils bloquent bien l'ovulation, ça permet d'abaisser leur dose. Ils ont une faible activité androgénique, clinique et métabolique.

(12:29 - 12:56)

Malheureusement, les dernières études ont montré qu'ils ont un petit peu plus de risque de thrombose par rapport à ceux de la deuxième génération. C'est pour cela qu'on utilise actuellement les pilules de deuxième génération, qui contiennent un progestatif de deuxième génération, en première intention. Actuellement, les pilules qui contiennent un progestatif de première ou de deuxième génération sont presque en première intention.

(13:00 - 13:19)

La montaction de la pilule, ou bien des méthodes oestro-progestatives, il n'y a que les combines actuellement. Alors, du fait qu'ils sont pris, ils entraînent un rétro-contrôle de l'axe hypothalamo-hépophyzaire. Ils entraînent un rétro-contrôle de l'axe hypothalamo-hépophyzaire.

(13:20 - 13:43)

Et donc, ils vont bloquer les pics de GnRH. Et s'ils bloquent les pics de GnRH, ils vont bloquer l'ovulation. Donc, en plus de leur action, en bloquant l'axe hypothalamo-hépophyzaire, ils vont épaissir la glaire cervicale.

(13:43 - 13:56)

C'est surtout l'action de la progesterone, et qui rend donc cette glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes. Ça, c'est la deuxième action. La troisième action, c'est une action sur l'endomètre.

(13:57 - 14:16)

Du fait des progestatifs, ils vont entraîner une atrophie de l'endomètre, et donc une impossibilité de l'implantation de l'œuf. Donc là, on voit un schéma qui montre un cycle normal où la femme ne prend pas de pilules. On voit les pics de FSH et de LH.

(14:17 - 14:29)

On voit les fluctuations hormonales au cours du cycle. Et on voit l'endomètre après démonstration, première phase du cycle. Et la deuxième phase du cycle où l'endomètre est prolifératif et sécrétoire.

(14:30 - 14:40)

Ceci quand la femme ne prend pas la pilule. Quand la femme prend la pilule, il y a un blocage de l'axe hypothalamo-hypophyzaire. Ce qui fait qu'il n'y a pas les pics de FSH et de LH.

(14:42 - 15:01)

Donc s'il n'y a pas de pics de FSH, il ne va pas y avoir d'ovulation. Et il ne va pas y avoir de sécrétion par l'ovaire d'oestrogène de la progestérone, donc les sécrétions sont nues. Et l'endomètre ne va pas subir la prolifération et devenir sécrétoire.

(15:02 - 15:19)

Donc cette action sur l'axe hypothalamo-hypophyzaire va bloquer l'ovulation. Et on va avoir également un blocage de la prolifération de l'endomètre qui va devenir inapte à l'annulation. Et en plus la glaire cervicale va être épicée du fait de l'action de la progestérone.

(15:24 - 15:43)

Alors les oestres progestatifs se prescrivent 21 jours par cycle, suivi de pauses de 7 jours entre les plaquettes. C'est durant cette pause où surviennent les règles. Alors quels sont les risques liés à ces oestres progestatifs? Le premier risque c'est le risque de thrombose veineuse.

(15:43 - 15:51)

C'est des hormones. Tous les hormones ont ce risque-là. Elles peuvent avoir des effets métaboliques sur les lipides et sur les glycidés.

(15:51 - 16:05)

Elles peuvent les perturber. Elles sont métabolisées au niveau du foie, donc elles peuvent entraîner des problèmes hépatiques. Bien sûr que lorsque c'est associé au tabac, elles augmentent le risque cardio-respiratoire par 50, très important.

(16:07 - 16:23)

Parmi les choses qui sont bénéfiques de la pilule, on a remarqué qu'elles diminuent les cancers de l'ovaire et les cancers de l'endomètre. Ça c'est des statistiques. Donc ce sont les effets des oestres progestatifs.

(16:23 - 16:47)

Donc risque de thrombose, risque de perturbation du métabolisme des glycidés et des lipides, problème hépatique et l'effet néfaste de l'association du tabac. L'effet bénéfique c'est qu'elles diminuent les cancers de l'ovaire et de l'endomètre. Il faut qu'on ajoute que les femmes qui prennent la pilule ont des cycles plus réguliers que les femmes qui prennent les autres méthodes de contraception.

(16:48 - 17:06)

Donc la pilule oestrogène progestatif permet de diminuer la quantité des règles et de régulariser le cycle menstruel. Alors pour les risques également, il faut éviter les oublis. Pour la pilule minidosée, il ne faut pas que l'oubli soit supérieur à 12 heures.

(17:07 - 17:48)

Il y a certains incidents mineurs, surtout en début d'utilisation, comme les nausées, les vomissements, qui vont disparaître lorsque la prise se prolonge. Alors les contre-indications absolues, bien sûr la grossesse, bien sûr le cancer du sein, quand il y a un cancer du sein dans les antécédents, c'est une contre-indication absolue à la contraception. Alors les oestrogènes progestatifs sont contre-indiqués lorsque la femme allècte au début, l'allèctement a fait 6 mois.

(17:49 - 18:02)

Bien sûr l'association du tabac et l'âge au-delà de 35 ans c'est une contre-indication absolue. Les hypertension artérielles qui ne sont pas bien contrôlées. Les diabètes anciens avec rétinopathie.

(18:03 - 18:15)

Les embolies pulmonaires et les flébités, les problèmes de thrombose sont des contre-indications absolues. Les anomalies de la coagulation. Chirurgie avec une blessure prolongée.

(18:15 - 18:28)

Les cardiopathies ischémiques. En rouge les migraines avec des symptômes focaux qu'on appelle des auras. Les migraines avec des symptômes focaux c'est également une contre-indication absolue à la contraception.

(18:29 - 18:57)

Bien sûr tout ce qui est hépatique, le métabolisme au niveau du foie, s'il y a un problème

hépatique, ils vont être contre-indiqués. Alors là également l'interaction avec certains médicaments, surtout dans notre pays où il y a beaucoup de tuberculose. Sachez que l'arrivée en piscine diminue, réduit l'intensité de la contraception.

(18:58 - 19:17)

Donc c'est établi que ça réduit l'efficacité de l'arrivée en piscine. Donc l'association il ne faut pas la faire. Également l'association avec les antifongiques comme la grésiophilamine et l'association avec les antifongiques c'est bon et les cétatifs.

(19:18 - 19:30)

Faites attention parce que ces associations là vont diminuer l'action de la contraception. Ce qui est établi, les autres ce n'est pas établi. Donc il faut retenir que l'arrivée en piscine diminue l'efficacité de la contraception.

(19:31 - 19:43)

En même temps que la grésiophilamine et certains antifongiques c'est bon et les cétatifs. Ça il faut le retenir. Alors on a terminé avec les œstroprogestatifs combinés.

(19:43 - 19:57)

Maintenant on va parler des méthodes qui contiennent de la progestérone seule. Il y en a ceux qui sont pris par voie orale, les injectables, les implantables, l'EDU à la progestérone. Donc pour ce qui est des microprogestatifs.

(19:57 - 20:10)

La différence avec les œstroprogestatifs c'est qu'ils ne bloquent pas l'axe hypothalamo-hypophysaire. Leur action est essentiellement une action périphérique. C'est à dire au niveau de la glaire cervicale qu'elles épaississent et au niveau de l'endomètre.

(20:11 - 20:34)

Donc c'est tellement faiblement dosé que souvent ils n'ont pas d'action au niveau hypothalamo-hypophysaire. Il va y avoir une ovulation mais l'endomètre et la glaire cervicale vont s'opposer à la grossesse. Du fait qu'ils sont très faiblement dosés, ils doivent être pris en continu sans interruption entre les plaquettes et à heure fixe.

(20:36 - 20:52)

Et du fait qu'ils sont très faiblement dosés, c'est la contraception de prédilection chez les femmes dans le postpartum. Alors, ceci concernant les microprogestatifs. Il y a des injectables à l'acétate de mitoxyprogesterone.

(20:53 - 21:18)

L'acétate de mitoxyprogesterone, ce sont des progestatifs injectables tous les 3 mois. Et il y a les implants qu'on insère en sous-cutanée et qui ont une action de 5 ans. Et bien sûr, il y a le dispositif interacteur qui contient de la progesterone, le célèbre Mirena.

(21:21 - 21:42)

Enfin, seuls, ils ont certaines contre-indications, notamment ceux qui sont les macro-dosés. Donc, il y a risque thromboembolique, vécus évolutifs, ça c'est une contre-indication. Les antécédents d'accident thromboembolique, vécus artérielles.

(21:42 - 21:58)

Bien sûr, sauf pour les microprogestatifs qui donnent peu de progestatifs, l'implant et le DIU. Pour les injectables, ils sont contre-indiqués, surtout pour les injectables. Les tumeurs sensibles à la progesterone, notamment le cancer du sein et le cancer ventromètre, c'est des contre-indications.

(21:58 - 22:21)

Les hémorragies génitales non expliquées. Et la présence ou l'antécédent de pathologies hépatiques sévères, du fait du métabolisme. Donc, dans ces contre-indications, à part les microprogestatifs, l'implant et le DIU, les injectables vont avoir des contre-indications similaires aux oestroprogestatifs, notamment les thromboses veineuses et les cancers et les problèmes hépatiques.

(22:26 - 22:50)

Alors, la prescription de cette contraception, il faut faire un interlocutoire pour chercher les contre-indications. Et lorsqu'il y a des antécédents personnels au milieu du métabolisme, des états du carbone ou lipidique, ou bien des problèmes cardiovasculaires, on va demander des examens avant de prescrire cette pilule. Lorsqu'il y a des antécédents, ce n'est pas pour toutes les femmes.

(22:51 - 23:21)

Là, on va demander un bilan minimal, une glycémie H1, un problème de cholestérolémie, triglycéridémie et un bilan des menstruations. Si elle est normale, on peut démarrer la contraception chez ces femmes qui ont des antécédents. Donc, on a parlé de la contraception hormonale, les oestroprogestatifs combinés et la progesterone, les progestatifs seuls.

(23:21 - 23:58)

Maintenant, on va parler de la deuxième catégorie des méthodes contraceptives, entre parenthèses mécaniques, mais on va voir qu'il y a également ceux qui contiennent de la progestérone. Ce dispositif intermédiaire, ou bien le stérilet, son indication idéale, c'est la multigeste, c'est-à-dire que c'est les femmes qui ont une vie sexuelle stable et un appareil génital sain. Vous voyez que c'est un corps étranger, donc s'il y a des infections, il y a un risque de complications.

(24:00 - 24:49)

Donc, ça nécessite l'indication idéale, une femme qui a deux enfants, trois enfants et qui veut une contraception qui ne contient pas de l'hormone, c'est le cuivre, ça c'est l'indication idéale. Alors, dans ce dispositif intermédiaire, il y a ceux au cuivre, les classiques, les anciens, qui ont une durée d'action de 5 jusqu'à 10 ans et ils agissent essentiellement par l'inflammation qu'ils vont entraîner au niveau de la cavité de l'endomètre. Actuellement, il y a d'autres dispositifs intermédiaires qui contiennent de la progestérone, qui ont également une durée d'action de 5 ans, qui agissent, en plus de leurs effets barrières mécaniques, ils agissent en rendant l'endomètre atrophique, donc un propre à l'anédation.

(24:54 - 25:36)

Alors, les contre-indications, bien sûr, des tests stérilisés, des dispositifs intra-utérins, bien sûr, la grossesse, tout ce qui est infection pile bien aiguë, bien sûr, les malformations utérines importantes, lorsqu'il y a un utérus bicorne ou un utérus cloisonné, ça peut entraîner des échecs. Lorsqu'il y a des hémorragies génitales non étiquetées, non diagnostiquées, suspicion de cancer génital, c'est une contre-indication. Vu que c'est un corps étranger, les valvulopathies avec un risque d'endocardisme sont également des contre-indications de ces dispositifs intra-utérins.

(25:38 - 26:10)

Les complications des dispositifs intra-utérins sont classiques, il faut les connaître, il faut les retenir. Il y a des femmes qui se plaignent de saignements lorsqu'ils ont un DIU plus important, et ces saignements sont essentiellement plus importants avec les stérilisés au cuivre. Parmi les complications, si on peut dire ça, il y a un risque d'expulsion qui peut être connu ou bien méconnu et être source d'échecs, surtout lorsqu'ils ne sont pas bien insérés.

(26:11 - 26:21)

Ça survient essentiellement les trois premiers mois. Lors de ces expulsions, ça fait essentiellement les trois premiers mois. Également au cours de l'insertion, il y a un risque de perforation ou de migration.

(26:23 - 26:49)

Si on ne respecte pas les contre-indications, il y a un risque d'infection, notamment une maladie inflammatoire du pelvis. Et bien sûr, il y a également un risque de JU avec le dispositif intra-utérin. On a parlé de la contraception hormonale, progestative, progestatif seul, on a parlé du dispositif intra-utérin, que ce soit au cuivre ou que ce soit à la progestérone.

(26:49 - 27:04)

Maintenant, on va parler de la contraception d'urgence ou bien de la contraception du post-partum. Ce n'est pas une vraie contraception. Ça ne devrait pas être utilisé de façon courante, mais ça doit rester une exception.

(27:06 - 27:25)

Comment il agit ? Du fait des hormones qui se sont prises, ils vont rendre l'endomètre inapte à l'implantation après un rapport sexuel mal ou non protégé par de fortes doses d'hormones. Il ne doit pas être habituel. Il n'est pas toujours efficace.

(27:25 - 27:45)

Il est efficace dans les trois jours qui suivent le rapport sexuel. J'ai rapporté là deux produits qui sont disponibles dans le marché, le Norlevo et le Postino. Tous les deux, c'est du levonorgestrel à 1,5 mg.

(27:47 - 28:12)

Donc, ça doit être pris lorsque la femme a un rapport sexuel non protégé et qu'elle ne veut pas tomber enceinte. Elle peut prendre cette pilule du lendemain pour rendre l'endomètre inapte. Ça a une certaine efficacité de 80 à 90 %. Alors, en conclusion, il n'y a pas de contraception idéale.

(28:12 - 28:28)

Chaque femme, chaque couple choisit sa contraception. Il y a des contradictions à la pilule dont le dépistage repose essentiellement sur l'interrogatoire. Le bilan, on le fait lorsqu'il y a des antécédents familiaux.

(28:30 - 28:55)

Les accidents thromboemboliques veineux sont le principal problème de la pilule, quel que soit le dosage et dès les premiers mois d'exposition. Donc, l'interrogatoire et le respect des contre-indications diminuent ce risque. Bien sûr, l'âge au-delà de 35 ans avec le tabac, c'est une contre-indication absolue à la pilule.

(28:59 - 29:21)

La contraception est un moyen de prévenir l'interruption volontaire de grossesse, qui est un

problème. Quand on a oublié la pilule, dans les cas exceptionnels, la pilule du lendemain d'urgence reste une alternative pour éviter justement de tomber dans le risque d'interruption volontaire de grossesse.